

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	川崎氏症 Kawasaki disease				
編號	A31000-Q03-W-N29	制定者	R10 陳倩芳/陳怡如	公布日期	113 年 10 月 08 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.1 版/5 頁	審查者		檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解川崎氏症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，使護理人員有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 定義

川崎氏症(Kawasaki disease)又稱黏膜皮膚淋巴結症候群(mucocutaneous lymph node syndrome)，為兒童後天性心臟病的主因，屬永久重大傷病。發病原因不明，常發生 5 歲以下兒童，為兒童後天性心臟病最常見的疾病，嚴重可能導致死亡。

(二) 臨床症狀

臨床上會有：1.持續 5 天或 5 天以上之發燒。2.眼結膜發紅無分泌物。3.軀幹皮膚出現疹子。4.上呼吸道及口腔黏膜改變，如：嘴唇乾裂，舌頭呈「草莓舌」，咽喉發炎，紅腫。5.四肢末稍紅腫、手掌及腳掌脫皮。6.頸部淋巴結腫大，直徑都在 1.5 公分以上。7.約有 5-30%的機率會有冠狀動脈異常的變化。

(三) 診斷及常見檢驗檢查

1. 診斷仍以臨床表現為主，診斷要件為持續發燒 $38^{\circ}\text{C} \geq 5$ 天以上，合併臨床症狀除了發燒的其中四項。台灣新生兒全面接種卡介苗，卡介苗接種處常有出現紅腫或潰瘍，也是川崎氏症的特色診斷之一。

主題名稱	川崎氏症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

2. 可能的檢驗數值異常

- (1) 正常或升高的白血球計數且以嗜中性血球為主
- (2) 急性期紅血球沉澱率(ESR)上升
- (3) 急性期 C 反應蛋白增加及低鈉血症(hyponatremia)
- (4) 低白蛋白血症(hypoalbuminemia)
- (5) 血清肝酶升高(elevated serum liver enzymes)
- (6) 無菌性膿尿(sterile pyuria) 發燒後第 2 週起血小板增加

(四) 川崎氏症的治療

1. 因為病因未明瞭，所以沒有針對病原的特殊療法。
2. 急性期常合併使用靜脈注射高劑量免疫球蛋白(2gm/kg)與高劑量阿斯匹靈 (Aspirin) (80-100 mg/kg/day)，退燒後改使用低劑量的阿斯匹靈 (Aspirin) (3-5mg/kg/day)。
3. 支持性療法：使用類固醇來抗過敏及發炎反應。
4. 如已併發冠狀動脈瘤形成的病患，則需要繼續長期追蹤治療。

(五) 護理問題

1. 口腔黏膜異常/與川崎氏症導致口腔黏膜破損有關
2. 皮膚狀態不完整/與造成皮膚脫皮及全身皮疹有關
3. 照顧者感到緊張/與對川崎氏症相關資訊陌生及無照顧經驗有關

(六) 護理措施

1. 口腔黏膜異常/與川崎氏症導致口腔黏膜破損有關
 - (1) 進食後 30 分鐘內及睡前，執行口腔清潔以減少食物殘渣對口腔黏膜及牙齒的刺激。
 - (2) 使用凡士林或護唇膏塗抹於個案唇部，減少嘴唇乾裂不適。
 - (3) 少量多餐，提供冰涼無刺激的軟質食物，例如：冰淇淋、豆花、布丁、愛玉等冰涼軟質食物，降低口腔黏膜刺激。
 - (4) 避免提供會刺激口腔黏膜的食物，如：酸辣、過燙及堅硬的食物。

主題名稱	川崎氏症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

(5) 每班評估口腔黏膜情況。

(6) 鼓勵個案多喝開水，可增加口腔濕潤度。

2. 皮膚狀態不完整/與造成皮膚脫皮及全身皮疹有關

(1) 每班檢查個案的全身皮膚，注意有無紅疹、脫皮、傷口或腫脹，並記錄皮膚的狀況。

(2) 每 2 小時協助個案更換姿勢，避免某部位長時間壓迫，如：左側躺、右側躺及平躺等。

(3) 保持床單清潔且沒有皺摺，床上不可留有異物，避免個案躺在不平處，勿選擇有拉鍊衣服，避免施加壓力，造成皮膚受壓損傷。

(4) 保持皮膚乾燥，床單、衣服潮濕盡快更換。

(5) 衛教可穿著易吸汗的棉質衣服並定時更換。

(6) 洗澡時宜注意水溫，可先用手背確認水溫，避免造成皮膚及傷口刺激。

(7) 使用中性沐浴乳和清水清洗，維持身體清潔。

(8) 沐浴後可擦拭中性乳液、保護油，避免乾裂。

3. 照顧者感到緊張/與對川崎氏症相關資訊陌生及無照顧經驗有關

(1) 給予川崎氏症照護之衛教單張，衛教症狀有持續發燒 5 天以上、全身皮疹、嘴唇乾燥破皮、雙側眼紅、四肢末梢水腫脫皮等症狀。

(2) 提供發燒照護之衛教單張，且衛教發冷期可增加被蓋；發熱期可適時補充水分，可給予藥物降溫；散熱期可適當的保暖、擦汗或替換乾爽的衣服。

(3) 須注意個案小便量是否減少、哭泣時是否眼淚量變少。

(4) 給予川崎氏症相關併發症之衛教資料，包含：心臟疾病、無菌性腦膜炎、尿道炎等常見併發症及照護注意事項。

(5) 主動告知施打免疫球蛋白期間及施打完 24 小時之內易引起臉部潮紅或臉色蒼白、紅斑、呼吸困難、發癢、低血壓、噁心或嘔吐等副作用，若有相關症狀發生，需立即告知護理人員。

主題名稱	川崎氏症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

(6) 衛教曾注射免疫球蛋白，會影響活性疫苗的效果，施打疫苗前請事先告知醫師個案情形。

(7) 衛教服用阿斯匹靈藥物，主要取用抗發炎作用，但同時有抗凝血作用，會引發出血時間延長，注意身上有無瘀青、牙齦流血及解便有血情況，並教導個案應避免碰撞或外傷。

(8) 衛教川崎氏症可能會導致動脈血管瘤及心臟的合併症，出院後仍須按照醫師指示定期做心臟超音波，追蹤心臟功能。

(9) 出院後，仍須依照醫師指示服用藥物，並回門診追蹤。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 穆佩芬、李美銀、曾韻珊、孫瑞瓊、朱世明、吳怡萱...陳金彌(2023)．免疫系統異常患童的護理·於穆佩芬總校閱，兒科護理學（二版，378-380 頁），新文京開發。
- (二) 張菡文、趙家伶（2024）．照顧一位川崎氏症學齡期病童的護理經驗．領導護理，25(1)，22- 34 。[https://doi.org/10.29494/LN.201406_15\(2\).0008](https://doi.org/10.29494/LN.201406_15(2).0008)

七、附件

(略)

主題名稱	川崎氏症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N29	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
113.10.08	1.0	新制定	113 年 09 月 11 日護理長會議通過;113 年 10 月 08 日督導會議通過公布。
114.10.08	1.1	第三項第一目英文大小寫修訂	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過;114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。